

Sémiologie du Syndrome Coronarien Aigu (SCA)

Pr H.Benabderrahmane

Unité Maladies métaboliques et Nutritionnelles

Service Médecine Interne

CHU Dr Benbadis Constantine

Faculté de Médecine, Université Constantine3 Salah Boubnider

Objectifs

- Préciser les caractéristiques sémiologiques d'une douleur angineuse
- Préciser les caractéristiques sémiologiques d'une douleur d'infarctus du myocarde

Plan du cours

Introduction

Définition du SCA

Rappel anatomique

Rappel physiopathologique

Sémiologie clinique :

- Caractéristiques semiologiques de la douleur angineuse
- Caractéristiques semiologiques de la douleur du SCA (infarctus du myocarde ST+, ST-, angor instable)

Conclusion

Références

**Selon programme national sémiologie 3eme Année Médecine
Année Universitaire 2024-2025**

Introduction

La douleur thoracique est une cause fréquente d'admission aux urgences. Les causes de ces douleurs thoraciques d'origine cardio-vasculaire sont multiples :

- l'insuffisance coronaire est de loin la cause la plus fréquente, qu'il s'agisse de l'angor ou de l'infarctus myocardique.
 - les autres étiologies cardio-vasculaires sont par ordre de fréquence décroissante la péricardite aiguë, l'embolie pulmonaire, la dissection aortique et certains troubles du rythme douloureusement ressentis.
- Reconnaître le SCA, urgence cardiovasculaire par définition, est donc fondamental dans une prise en charge urgente de qualité.

Définition

Le syndrome coronarien aigu correspond à une Ischémie myocardique aiguë qui va conduire à la nécrose myocardique, accompagnée de douleur thoracique angineuse persistante au repos de manière prolongée.

La classification actuelle dépend de l'électrocardiogramme (ECG) d'admission.

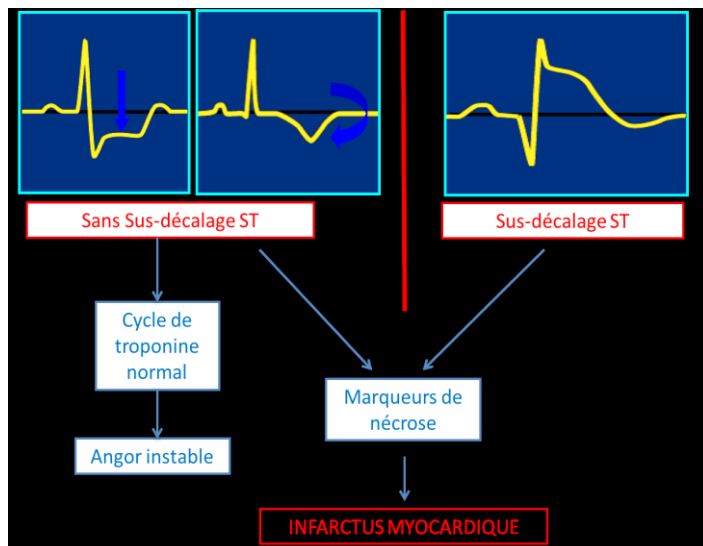
• **Les SCA avec sus-décalage du segment ST (STEMI ou ST Elevation Myocardial Infarction)** impliquent habituellement une occlusion thrombotique complète de l'artère coronaire et nécessitent une désobstruction urgente.

• **Les SCA, sans sus-décalage du segment ST (NSTEMI-ACS, non ST Elevation Acute Coronary Syndrome)** regroupent des patients de gravité très variable et représentent environ 70 % des cas.

Leur diagnostic est plus difficile que celui des STEMI car il est possible qu'il n'existe aucune modification de l'électrocardiogramme suggestive d'ischémie. Leur prise en charge doit donc être adaptée à l'évaluation pronostique.

- En l'absence d'élévation des troponines, on parle **d'angor instable**

- A l'inverse, l'élévation des troponines caractérise **les patients avec un NSTEMI (infarctus sans sus-décalage du segment ST, Non-ST Elevation Myocardial Infarction)**.



Rappel anatomique

Les artères coronaires droite et gauche proviennent des sinus coronaires droit et gauche dans la racine de l'aorte, juste au-dessus de l'orifice valvulaire aortique.

-L'artère coronaire gauche commence par un tronc commun et se divise rapidement en une artère interventriculaire antérieure (IVA) et une artère circonflexe, et parfois avec une artère intermédiaire (ramus intermedius).

-L'artère interventriculaire antérieure suit habituellement le sillon interventriculaire antérieur et, chez certains individus, continue jusqu'à la pointe. Cette artère nourrit la partie antérieure du septum (y compris le système de conduction proximal) et la paroi libre antérieure du ventricule gauche.

-L'artère circonflexe, habituellement plus petite que l'artère interventriculaire antérieure, vascularise la paroi libre latérale du ventricule gauche.

Rappel physiopathologique

► **D'abord un rappel sur l'angor stable (angor d'effort ou syndrome coronarien chronique SCC) :** l'angor stable est la conséquence de la formation d'une plaque d'athérome dans l'intima d'une coronaire créant une sténose. On l'appelle « stable » car la plaque d'athérome est « stable », c'est-à-dire qu'elle n'occlut pas complètement le vaisseau ni n'est sur le point de se rompre.

En l'absence d'effort, un faible débit sanguin circule dans les coronaires en raison des faibles besoins. Lors de l'effort, le débit augmente mais le vaisseau ne pouvant se dilater, il apparaît une inadéquation entre apports et besoins avec libération de métabolites comme l'adénosine stimulant les terminaisons nerveuses à l'origine de la douleur thoracique.

► **Le syndrome coronarien aigu** regroupe 3 types d'ischémie myocardique :

■ le SCA avec sus-décalage du segment ST (**STEMI**) = occlusion totale de la coronaire par un thrombus ;

■ le SCA sans sus-décalage du segment ST (**NSTEMI**) = thrombus non occlusif :

→ troponine positive : thrombus non occlusif mais avec embolie distale expliquant l'augmentation des troponines réactionnelles à la souffrance des myocytes ;

→ troponine négative : angor instable : thrombus non occlusif sans embolie distale.

Le SCA représente donc, le plus souvent, une complication aiguë de l'athérosclérose : c'est **la rupture d'une plaque d'athéro sclérose et la formation d'un thrombus intra coronaire partiellement ou totalement occlusif**, responsable d'une diminution sévère ou d'une interruption transitoire et partielle (NSTEMI) ou prolongée (STEMI) du débit coronaire.

-Notons, toutefois, qu'une sténose significative (au moins une sténose > 70 % de réduction du calibre luminal (50 % pour le tronc commun de la coronaire gauche) peut occasionner un angor instable secondaire lorsque les conditions métaboliques augmentent les besoins du myocarde en oxygène tels un état fébrile avec ou sans sepsis, une hyperthyroïdie ou une anémie.

-Dans de rares cas, le SCA n'est pas lié à l'athérosclérose, par exemple en cas d'embolie coronaire.

Sémiologie clinique

Avant d'aborder la sémiologie du syndrome coronarien aigu, il est indispensable de décrire les caractéristiques semiologiques de la douleur angineuse tel que décrite dans l'angor stable

► Caractéristiques sémiologiques de la douleur angineuse (Angor stable) à l'anamnèse

Siège	Diffus mais souvent rétrosternal ou médiosternal gauche (mais aussi épigastrique ou dans le dos).
Irradiation	Très évocateur si mâchoire, cou et épaule et bras gauche principalement. Mais aussi épaule droite, dos.
Type	Constrictif à type d'oppression en barre (d'une épaule à l'autre). Pour manifester cette oppression : le signe de Levine qui consiste, pour le patient, à placer son poing serré sur sa poitrine pour décrire ses symptômes.
Début circonstances apparition	Uniquement à l'effort : marche, montée escaliers, effort inhabituel
Durée	Cède rapidement (dans les 5 minutes) après arrêt de l'effort ou après la prise de trinitrine sublinguale.
Intensité	Variable, de la gêne thoracique à la douleur presque syncopale.
Signes d'accompagnement	aucun
ECG	normal ou signes d'ischémie

Examen clinique

Dans la majorité des cas, il ne retrouve rien. Mais certains signes peuvent cependant nous aider et nécessitent d'être recherchés :

- souffle vasculaire carotidien/fémoral** qui signifie une localisation athéromateuse sur un autre axe vasculaire et renforce notre hypothèse ;
- souffle aortique systolique en faveur d'un rétrécissement aortique** qui est une cause d'angor non coronarien

-signes d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) :car l'AOMI témoigne indirectement de l'existence très probable de lésions atheromateuses coronaires

► **Caractéristiques semiologiques de la douleur angineuse lors du Syndrome Coronarien aigu (Infarctus du myocarde aigu ST+, ST-, Angor instable) à l'anamnèse**

Le diagnostic de syndrome coronarien nécessite avant tout la présence d'une **douleur thoracique évocatrice** (même si des exceptions existent notamment chez le sujet âgé et chez le diabétique).

Siège	Rétrosternal en barre
Irradiation	Dans la mâchoire et le bras gauche, mais parfois épigastre, bras droit, dos. Attention, la douleur thoracique peut ne pas être présente et limitée uniquement aux irradiations. L'irradiation au bras droit aurait une meilleure valeur diagnostique.
Type	Oppression, en étau.
Début	Brutal, au repos. Souvent, la douleur de SCA a été précédée dans les jours précédents de douleurs angineuses répétitives cédant spontanément après plusieurs minutes de repos et caractéristiques d'angor instable (angor repos, angor de novo, angor crescendo)
Durée	> 20 minutes. Ne cède ni par le repos, ni pas la prise de trinitrine (différence avec l'angor stable) mais cède aux opiacés
Intensité	Souvent violente, mais peut être diminuée chez le sujet âgé et le patient diabétique du fait de la neuropathie.
Signes d'accompagnement : fréquents : agitation, angoisse, pâleur, sueurs froides et troubles digestifs : nausées, vomissements, éructations.	
ECG : lors des premières heures signes ischémie et ou lésion parfois signes de nécrose	

-pour les circonstances d'apparition de la douleur du SCA :Un angor instable(angor de repos ou angor de novo ou angor crescendo) a souvent précédé les jours précédents la douleur du SCA

Ainsi, l'angine de poitrine s'aggrave rapidement quant à la fréquence et à la durée de la douleur, souvent de durée plus longue que l'angor d'effort:

-soit apparition et répétition des crises d'angor spontané :angor de repos

-soit apparition des premières crises d'angor d'emblée sévères, c'est l'angor de novo.

-soit diminution rapide du seuil des efforts déclenchant les crises d'angor, c'est l'angor aggravé: angor crescendo

-Remarque : Pour la douleur du SCA du ventricule droit

Le ventricule droit étant situé en sous-xiphoïdien, la douleur peut ne pas être thoracique mais située au niveau du creux épigastrique.

En cas de douleur épigastrique, il convient donc de réaliser un ECG avant même de penser aux causes plus fréquentes telles que l'ulcère, la pancréatite et la colique hépatique

-On recherchera des facteurs ayant déclenché un syndrome coronarien aigu en entraînant un déséquilibre des besoins/apports en oxygène du myocarde :

- **fièvre** : infection entraînant un apport en oxygène plus important **via** une augmentation du débit cardiaque ;

-**anémie** : pâleur, tachycardie, dyspnée ; d'autant plus qu'elle est d'apparition aiguë ;

-**hypoxémie** : pneumonie, exacerbation de BPCO...

Examen clinique

En premier lieu, on recherche des signes de mauvaise tolérance hémodynamique pouvant orienter vers un choc cardiogénique :

-hypotension, tachycardie

-œdème aigu pulmonaire avec présence de crépitants pulmonaires bilatéraux

-oligurie

-marbrures

-signes de détresse respiratoire aiguë : tirage musculaire, balancement thoraco-abdominal.

Ensuite, l'examen recherche des signes orientant vers une complication du SCA :

- souffle d'insuffisance mitrale (IM fonctionnelle due dilatation anneau sur VG dilaté en souffrance)
- souffle de CIV (en cas infarctus antérieur)
- frottement péricardique (suite à une probable péricardite précoce)
- syncope en cas de bloc auriculo-ventriculaire

Conclusion

La douleur des syndromes coronariens aigus est semblable à celle de l'angor ; Toutefois elle s'en distingue par des particularités qui permettent de l'identifier facilement :

- par son intensité, la douleur étant fréquemment intolérable avec angoisse et « sensation de mort imminente ».
- par sa diffusion très large avec de multiples irradiations néanmoins la douleur peut se limiter à l'une de ses irradiations
- par sa prolongation pendant 20 minutes et plus, caractère confirmé par sa résistance à la trinitrine (cède aux opiacés)
- par la présence fréquente de signes d'accompagnement : nausées, voire vomissements, sueurs...

Enfin, il est nécessaire de savoir que la pauvreté de l'examen clinique ne doit pas faire écarter le diagnostic de SCA

Références

1-ALMANGE, C., ANDRÉ-FOUËT, X., AUMONT, M. C., *et al.* Sémiologie Cardiologique. *Collège National des Enseignants de Cardiologie*, 2006.

2-KHALLOUKI, Mohamed et SAMKAOUI, Mohamed Abdenasser. Syndromes coronaires aigus. *Le Praticien en Anesthésie Réanimation*, 2012.

3-GACH, Olivier, EL HUSSEINI, Ziad, et LANCELLOTTI, Patrizio. Syndrome coronarien aigu. *Revue Médicale de Liège*, 2018.